Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Rio Grande

Rua Apody dos Reis, 16, 6º andar, Sala 621 - Bairro: Cohab IV - CEP: 96214-264 - Fone: (53) 3036 8300 - Email: frriograND1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5025021-22.2024.8.21.0023/RS

AUTOR: TOME MARCOS TRINDADE

RÉU: UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária ajuizada por **TOME MARCOS TRINDADE**, representado pela sua genitora, Cristiane Barros Marcos, em face de **UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA**. Historiou que desde os seus sete meses de idade apresenta crises de alergia alimentar, inclusive com episódios de anafilaxia. Explicou que em manifestações mais graves pode haver choque anafilático, capaz de causar a morte se não for imediatamente tratado. Disse que recebeu diagnóstico de alergias alimentares múltiplas (CID 10 T780), estando até o momento confirmadas as alergias alimentares mediadas pela imonuglobulina E, isto é, ao leite e seus derivados, à banana, ao trigo e ao ovo. Afirmou que não obtiveram resultados imediatos, de modo que os testes de alergia são eliminatórios, sendo a gravidade definida após sucessivos testes de classificação e eliminação. Ressaltou as dificuldades diárias enfrentadas pelos seus responsáveis, os quais são obrigados a se manterem em constante alerta, carregando injeções de adrenalina, já que o demandante reage ao simples contato dessas substâncias com a sua pele. Asseverou a necessidade de iniciar tratamento para evitar ou amenizar esses episódios, além de propiciar atividades comuns ao requerente, sobretudo diante da aproximação da idade escolar. Noticiou que o único tratamento possível é o medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg, com aplicação subcutânea a cada 28 dias, capaz de mitigar reações alérgicas a mais de um alimento. Informou que o fornecimento do fármaco foi negado pela parte ré, por não estar ser coberto pelo rol de procedimentos da ANS, especialmente por não haver indicação do seu uso para menores de 6 anos. Contou que o remédio foi incorporado ao SUS em 2019 e possui cobertura obrigatória ao ser inserido no rol da ANS em fevereiro de 2021. Em sede liminar, postulou o fornecimento do medicamento. Ao final, requereu a procedência da ação para tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência pleiteada. Pugnou pela inversão do ônus da prova. Juntou documentos (Evento 1, docs. 2/17).

Recolhidas as custas iniciais (Eventos 6 e 16), foi deferida a medida liminar (evento 18, DOC1).

A requerida apresentou contestação (evento 38, DOC1). Esclareceu que a negativa decorreu do fato de inexistir cobertura contratual para fornecimento de medicamento considerado off-label e experimental, já que a bula indica seu uso para pacientes com mais de 6 anos, enquanto o demandante possui apenas 3. Negou dever de cobertura pela natureza experimental. Argumentou que não há validação científica ou empírica para o uso do fármaco objeto a lide no caso clínico do requerente. Mencionou também que o tratamento postulado não está previsto na cobertura obrigatória do plano de saúde por não estar contemplado na diretriz de utilização para a patologia do autor. Insurgiu-se quanto à inversão do ônus da prova. Juntou documentos (Evento 38, docs. 2/6).

Réplica no evento 42, DOC1.

Em saneamento, foi invertido o ônus da prova (evento 44, DOC1).

Em sede de instrução, as partes produziram prova documental (Eventos 48 e 49), sendo oportunizada vista à parte contrária.

O Ministério Público apresentou parecer final opinando pela procedência dos pedidos (evento 64, DOC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relato.

Passo a decidir.

O processo pode ser julgado no estado em que se encontra, pois os documentos apresentados são suficientes para tanto. Além disso, as partes não requereram a produção de outras provas (artigo 355, I, do CPC).

Pretende a parte autora o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg, com aplicação subcutânea a cada 28 dias, por ser portadora de Alergias Alimentares Múltiplas (CID 10 T 78.0).

Sobre o tema, o Egrégio STJ, através do julgamento dos EREsp 1.886.929 e EREsp n.º 1.889.704, julgado em 08/06/2022, firmou a tese a respeito da taxatividade do rol de procedimentos/tratamento da ANS, restando consolidada as seguintes diretrizes, *in verbis*:

(...)

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Em relação às quatro condicionantes do item "4", a seção citou os Enunciados 23, 33 e 97 das Jornadas de Direito em Saúde, que assim dispõe, *in verbis:*

ENUNCIADO Nº 23 Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.

ENUNCIADO Nº 33 Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec para auxiliar a prolação de decisão ou a propositura da ação. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

ENUNCIADO Nº 97 As solicitações de terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como equoterapia, hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura e/ou custeio obrigatório às operadoras de saúde se não estiverem respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com Prognóstico de Evolução.

Posteriormente, a Lei Federal n.º 14.454/22, estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol, nos seguintes termos*, sic:*

Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Diante desse contexto, das quatro condicionantes fixadas pela Corte Superior para excepcionar o Rol da ANS, remanescem as constantes nos itens "ii" e "iii" - **(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros.**

Assim, ainda que o medicamento ou tratamento postulado não esteja previsto no Rol da ANS, a excepcionalidade para fins de se determinar o dever de cobertura pela operadora do plano de saúde, fica condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I e II da Lei n.º 14.454/22.

Na hipótese, o medicamento em questão possui registro na Anvisa[1].

O diagnóstico da patologia que acomete o demandante é incontroverso, corroborado pelo laudo médico do evento 1, DOC6 e pelo receituário da nutricionista que acompanha a parte autora (evento 1, DOC10).

Veja-se que o médico assistente, por ocasião do laudo do evento 1, DOC6, ressaltou o que segue:

A medicação subcutânea de omalizumabe foi aprovada pelo FDA (Food and Drug Administration) para o tratamento de alergias alimentares mediadas por imunoglobulina E crianças com um ano ou mais. Este medicamento reduz o risco de reações alérgicas (Tipo I), que podem incluir anafilaxia, quando um indivíduo encontra acidentalmente um ou mais alérgenos alimentares. O omalizumabe funciona ligando-se à IgE e alterando as vias mediadas pela IgE, o que diminui a capacidade da IgE de causar reações alérgicas.

Em vista ao quadro clínico do paciente, e de que essa medicação é a ***ÚNICA aprovada para esse tipo de tratamento até o presente momento, e que ela é capaz de modificar o limiar de reação alérgica****, solicitamos com urgência que seja liberado o tratamento para este paciente com o intuito de melhorar qualidade de vida, além de diminuição de sintomas ocasionados pela ingesta ou contato acidental. (grifei)*

Nesse sentido, ainda que a medicação não possua indicação específica de utilização para a patologia que acomete o demandante, há notícia de que a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de saúde norte-americana de renome internacional, aprovou o uso de Omalizumabe (Xolair) para redução de reações alérgicas (tipo I),

incluindo anafilaxia, que podem ocorrer após exposição acidental a um ou mais alimentos em pacientes adultos e pediátricos a partir de um ano de idade com alergia alimentar mediada por IgE[2]. Tal aprovação por um órgão internacional de grande relevância atende diretamente ao requisito estabelecido no inciso II do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, mitigando a alegação de uso experimental.

Ademais, a parte autora fez prova de recomendação favorável emitida pelo e-NatJus para uso do remédio em questão em caso de alergia alimentar, conforme Notas Técnicas n.ºs 255587 e 265839 (evento 1, DOC12 e evento 1, DOC14).

Além disso, a Nota Técnica de n.º 209124 (evento 1, DOC13), em que pese não trate do mesmo diagnóstico patológico do requerente, evidencia a existência de recomendação favorável da medicação Omalizumabe para criança de apenas 1 ano de idade, comprovando que o fato do demandante ter 3 anos de idade, por si só, não pode ser um empecilho para que tenha acesso ao medicamento pretendido.

As Notas supracitadas corroboram a informação prestada pelo médico assistente quanto à aprovação do uso do fármaco para tratamento de pacientes com risco de reação grave após exposição acidental a alimentos alérgenos, bem como a notícia de que inexiste substituto, se tratando da única medicação capaz de mitigar as reações da patologia do requerente, contribuindo para a melhora da sua qualidade de vida.

Os apontamentos feitos pelo e-NatJus nas Notas contribuem para demonstrar a eficácia e segurança do medicamento em contextos similares, fortalecendo a tese de que o tratamento não se enquadra na vedação de "tratamento experimental" no sentido estrito da lei, especialmente quando há evidências científicas robustas e recomendação de organismos reconhecidos internacionalmente.

Oportuno esclarecer que a limitação do critério médico na escolha de procedimento para o tratamento da doença é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica, *in verbis:*

> *"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente".*

Dessa forma, cabe ao médico assistente, o qual é conhecedor do quadro clínico, determinar qual o tipo de tratamento mais adequado ao caso, prescrever os métodos e os procedimentos mais indicados para o paciente, bem como os materiais e medicamentos que deverão ser utilizados.

Ou seja, é vedado ao plano de saúde insurgir-se contra as determinações do médico quanto aos medicamentos e materiais utilizados no procedimento e que objetivam reduzir os riscos do paciente e, em consequência, os custos do plano de saúde, desde que comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas nos termos já expostos acima.

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO FÁRMACO OMALIZUMABE. ASMA BRÔNQUICA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. Incide o Código de Defesa do Consumidor à Espécie (Súmula nº 608 do Stj), por se Tratar de Típico Contrato de Adesão, o Que Possibilita A decretação da Nulidade das Cláusulas Que "Estabeleçam Obrigações Consideradas Iníquas, Abusivas, Que Coloquem o Consumidor em Desvantagem Exagerada, Ou Seja, Incompatíveis Com a Boa-fé Ou a Equidade", Bem Como Que as Cláusulas Contratuais Devem Ser Interpretadas de Maneira Mais Favorável ao Consumidor, Nos Termos do Artigos 6º, v, 47 e 51, iv, do Referido Diploma. 'A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico ou hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato' (REsp 183.719/SP). O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, bem como bem como o número de sessões, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada (STJ, Resp nº 668.216-SP, j. 15.03.2007). O rol de procedimentos previsto nas normas da ANS não é taxativo, traduzindo somente um referencial de coberturas básicas para os planos de saúde. Os planos de saúde devem incluir em sua coberturas os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Art. 21, XI, da RN 428/2017, da ANS. Além disso, a ANS não veda o uso off label de um medicamento com registro na ANVISA e comercialização nacional, o que não se confunde com tratamento experimental a que alude o art. 10 da Lei 9.656/98. O laudo e a prescrição médica acostados à inicial atestam que a autora tem diagnóstico de asma brônquica desde a infância, sendo que desde 2007 realiza tratamento ambulatorial para o controle da doença, apresentando uma perda progressiva da função pulmonar, sendo que atualmente possui apenas 26% de tal função, necessitando da utilização do medicamento OMALIZUMABE 150mg. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A negativa de cobertura, por si só, com base em interpretação das cláusulas contratuais e das normas regulamentadoras do setor não ultrapassa a esfera dos dissabores das relações contratuais, não ingressando na violação dos direitos da personalidade. No caso, a negativa, embora descabida, estava amparada por parecer técnico emitido pela auditoria médica da operadora do plano de saúde. Ademais, inexiste, nos autos, prova de que a condição clínica do autor tenha se agravado até o deferimento da tutela de urgência. Sentença reformada, em parte. Ação julgada parcialmente procedente. Redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50129717620198210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 17-09-2020)*

Assim, havendo cobertura contratual para a moléstia apresentada pela parte autora e estando o medicamento indicado pelo médico assistente registrado na ANVISA, inexistindo tratamento alternativo, incumbe ao plano de saúde demandado fornecer o medicamento ora prescrito, restando superada a questão da taxatividade do rol da ANS, nos termos da Lei n. 14.454/2022.

Outro ponto relevante para a decisão concerne à natureza da aplicação do medicamento. A parte ré argumentou a exclusão por se tratar de "medicamento de tratamento domiciliar". Contudo, a própria ré, em sua contestação, colacionou a Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que em seu art. 4º, inciso X, define *uso off-label* como o uso de medicamento para indicação que não está descrita na bula. A mesma Resolução, em seu art. 17, parágrafo único, inciso VI, define "medicamentos para tratamento domiciliar" como "aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente

externo ao de unidade de saúde". A parte autora, em réplica, demonstrou que a aplicação do Omalizumabe, por ser injetável e requerer supervisão médica em ambiente equiparado a clínicas ou hospitais devido ao risco de anafilaxia, não se configura como tratamento domiciliar.

Os comprovantes de aplicação em clínica especializada (Evento 48) reforçam a natureza ambulatorial da administração, equiparando-a à medicação assistida, que não se submete à exclusão prevista para medicamentos de uso domiciliar.

Portanto, tenho por evidenciada a responsabilidade do plano de saúde demandado pela cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente à parte autora, devendo ser procedente o pedido formulado na presente lide.

A propósito, cito precedentes em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IPE-SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO PELO ROL DA ANS. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que negrou provimento à apelação interposta contra sentença que condenou o IPE-Saúde ao fornecimento do medicamento "omalizumabe" como mecanismo para tratamento do diagnóstico de "Alergia à Proteina do Leite de Vaca" (CID 10 K52.2), com quadro de "anafilaxia" (CID T78.0). II. Questão em discussão: As questões em discussão nos autos idzem respeito à possibilidade de condenação da autarquia recorrente à concessão do medicamento postulado pela parte agravada, bem como ao critério adotado para fixação de honorários advocatícios. III. Razões de decidir: A Lei 14.454/2022 estabeleceu o rol exemplificativo da ANS com condicionantes, cuja aplicação permite excepcional cobertura de medicamento não listado, desde que observados os requisitos legais. A jurisprudência do STJ confirmou a possibilidade de fornecimento de tratamento fora do rol da ANS, desde que haja eficácia comprovada e respaldo técnico. Hipótese dos autos em que, considerando a gravidade do quadro do autor, devidamente comprovada pela documentação médica que ampara a pretensão autoral, bem como que o medicamento "omalizumabe" não foi expressamente indeferido pela ANS e que este destina a tratamento de natureza hospitalar - qual seja, o processo de dessensibilização a ser realizado em hospital -, a responsabilidade do recorrente encontra amparo no artigo 9º, "5" da Resolução nº 21/79-IPE-Saúde. Outrossim, não comporta reparo a sentença em relação à fixação de honorários de sucumbência, na medida em que, além de ser plenamente possível seu arbitramento por equidade no caso concreto, o valor fixado observou os parâmetros previstos no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese V. Tese de julgamento: ***1. É cabível a cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS, desde que demonstrada sua eficácia científica e a inexistência de tratamento substitutivo eficaz, em conformidade com a Lei 14.454/2022.*** *2. O plano de saúde público tem responsabilidade pela cobertura de tratamento hospitalar indicado por médico assistente, em especial quando não suficientemente impugnados os documentos médicos acostados pela parte autora. 3. O critério de equidade é aplicável à fixação de honorários advocatícios em causas com proveito econômico inestimável ou irrisório. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50028123420208210109, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado em: 25-09-2025) (grifei)*

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO CONTRA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR. RISCO DE CHOQUE ANAFILÁTICO DA PARTE AUTORA ACASO EM CONTATO COM O FATOR ALERGÊNICO. GRAVIDADE DA DOENÇA DEMONSTRADA, BEM COMO SEU ALTO CUSTO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO IPÊ-SAÚDE. 1. Não é todo e qualquer tratamento medicamentoso que o IPÊ-SAÚDE está obrigado a disponibilizar aos seus segurados, devendo ser demonstrada a gravidade da doença e o alto custo para a sua aquisição, situação demonstrada na hipótese. In casu, a parte autora é acometida de grave alergia alimentar, especificamente em relação à proteína do leite de vaca, necessitando do medicamento Omalizumabe 150mg injetável, fins de evitar choque anafilático acaso em contato com o fator alergênico, de modo que, ainda que se trate de tratamento de alto custo, cabe ao IPÊ-SAÚDE o seu fornecimento, notadamente diante da gravidade da enfermidade, devidamente atestada por Laudo Médico. 2. O IPÊ-SAÚDE tem o dever de fornecer o tratamento postulado, não excluído do plano de saúde, e devidamente indicado por médico competente ao paciente, vedada expressamente a limitação do critério médico na escolha de tratamento, nos termos do artigo 16 do Código de Ética Médica. Precedentes jurisprudenciais. ***3. Comprovada a necessidade do uso do fármaco postulado para o tratamento da grave alergia alimentar que acomete a parte autora, é dever do plano de saúde garantir as condições de saúde e sobrevivência dignas. Inteligência do art. 4º, da Lei Estadual nº 15.145/2018 e Resolução nº 21/1979. 4. A ausência de previsão de medicamento em listas do IPÊ-SAÚDE não impede a realização do tratamento necessário à saúde do paciente. O atestado médico do profissional devidamente habilitado que acompanha o tratamento da parte autora constitui prova suficiente para embasar a pretensão por ela explicitada na inicial, bem como a adequação do tratamento prescrito para a doença que lhe acomete.*** *5. Não há falar em invasão de competência de outro Poder ou desrespeito a princípios como o da Legalidade e Igualdade, vez que se está garantindo a observância da legislação aplicável ao caso, tratando-se de relação contratual, ou seja, plano de saúde. A autarquia não pode querer valer-ser da condição de fazenda pública nas discussões envolvendo a cobertura do plano de saúde. 6. Nos casos em que pleiteado tratamento médico, o verdadeiro objeto da ação é o direito à vida e à dignidade, bens estes de valor inestimável, de forma que os honorários de sucumbência devem ser fixados em consonância com o art. 85, §8º, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50012213320188210036, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 25-05-2022) (grifei)*

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **TOME MARCOS TRINDADE** em face de **UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, ao efeito de, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, compelir a parte ré a fornecer o medicamento Omalizumabe 150mg, com aplicação subcutânea a cada 28 dias, nos termos do laudo médico trazido na inicial, enquanto o médico entender necessário.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios devidos aos procuradores do autor, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 1.010, §1º, do CPC. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Enfim, em nada mais sendo requerido e satisfeitas as diligências quanto às custas eventualmente pendentes, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALINE ZAMBENEDETTI BORGHETTI, Juíza de Direito**, em 11/11/2025, às 19:00:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10094967205v36** e o código CRC **e8638020**.

1. https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/372342?nomeProduto=XOLAIR&substancia=22825 ↩
2. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-medication-help-reduce-allergic-reactions-multiple-foods-after-accidental?trk=public_post_comment-text&utm_source=chatgpt.com ↩